

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	小兒肺炎 Pediatric Pneumonia				
編號	A31000-Q03-W-N10	制定者	R10 陳倩芳	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.6 版/10 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解小兒肺炎的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，使護理人員有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

是指肺臟的一部份或全部發炎，包括氣管和肺泡的發炎，是一種下呼吸道感染。

（二）症狀

發燒（可能合併畏寒）、咳嗽（可能有痰）、胸痛（可能合併頭痛或腹痛）、呼吸急促或呼吸困難。

（三）常見檢查

- 1.血液檢查及培養(blood culture)。
- 2.CBC／DC。
- 3.高敏感度 C-反應性蛋白(HS C.R.P)。
- 3.動脈血氧分析(blood gas)。
- 4.痰液培養(sputum culture)。
- 5.胸部 X 光（由後向前和側面 X 光）(chest X-ray)。

（四）常見治療

主題名稱	小兒肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N10	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/10

1.藥物治療：

(1)Aminophylline。

(2)Bricanyl。

(3)Stazolin。

(4)Erythromycin。

(5)Penicillic G。

(6)Vancomycin。

(7)Ventolin。

(8)Zithromax。

2.支持療法。

3.膿胸者給予胸腔引流。

4.胸腔物理治療。

(五) 護理問題

1.呼吸道清除功能不良／分泌物黏稠。

2.發燒／感染。

3.無法有效呼吸／炎症反應過程。

4.氣體交換困難／肺泡與微血管膜改變。

5.(特定的)健康協助／對治療處置不瞭解。

(六) 護理措施

1.呼吸道清除功能不良／分泌物黏稠

(1)教導正確有效率深呼吸、咳嗽。

(2)聽診呼吸聲，評估並記錄分泌物的量、顏色、濃稠度。

(3)聽診呼吸聲，觀察並記錄呼吸型態、次數、發紺情形、皮膚顏色視病童需要給予姿位引流。

(4)給予噴霧治療、扣擊、抽痰。

(5)床旁隨時備妥抽痰器。

主題名稱	小兒肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N10	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/10

(6) 抽痰前後予 100%O₂，以提高含氧量。

(7) 以無菌技術抽痰，動作宜輕柔，避免黏膜損傷，壓力維持在 60-120mmHg 抽吸時間不超過 15 秒。

(8) 採分段餵食，並在餵食後予以排氣，抬高床頭 45-60 度，並留意有無嘔吐。

(9) 如呼吸過速，勿由口進食。

(10) 依醫囑給予靜脈注射補充體液，並維持適當的滴數。

(11) 依醫囑給予藥物，以減少氣管阻塞，並評估效果及副作用。

2.發燒／感染

(1) 向病童及其家屬說明體溫上升的原因。

(2) 教導病童及主要照顧者降低體溫的方法。

(3) 調整衣物被蓋及提供舒適室溫(24-26°C)並維持通風。

(4) 病童發燒引起寒顫時，在其四肢覆蓋毛巾保暖。

(5) 冰枕或冰寶使用。

(6) 病童流汗時給予擦乾，建議穿棉質衣服保持舒適及乾爽。

(7) 協助追蹤各項相關之檢驗報告結果。

(8) 依醫囑給予溫水拭浴（水溫 27-37°C，毛巾沾濕自病童雙側腹股溝、腿內側、膝窩、足跟、擦拭 8 分鐘）。

(9) 依醫囑給予解熱劑（藥名、劑量、途徑、時間）。

(10) 每 30 分鐘測量生命徵象至穩定並記錄。

(11) 依醫囑給予靜脈點滴輸液。

(12) 依醫囑給予抗生素注射。

3.無法有效呼吸／炎症反應過程

(1) 評估和記錄病童呼吸狀況，包括完整的健康史。

(2) 評估和記錄病童呼吸型態（速率、節律、肺部擴張、呼吸音、使用呼吸輔助肌、噁嘴呼吸、動脈血液氣體分析值和皮膚顏色）。

(3) 教導和協助維持最有效的呼吸姿勢。

主題名稱	小兒肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N10	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	4/10

(4) 指導並示範如何打呵欠、深呼吸和咳嗽。

(5) 協助病童日常生活活動，評估活動無耐力和提供休息時間以保留體力。

(6) 維持足夠營養攝取量以供呼吸肌和呼吸所需的熱量。

(7) 教導病童避免呼吸道刺激物和呼吸道感染。

(8) 依醫囑給予藥物和評估效果（例如：支氣管擴張劑、抗發炎藥物等）。

(9) 監測病童對以上治療措施的反應。

(10) 評估動脈血液氣體分析值、肺功能和病童一般臨床狀況改善情況。

4. 氣體交換困難／肺泡與微血管膜改變

(1) 監測組織缺氧的徵象：心智狀況改變、心跳過速、易怒和異常呼吸音，並報告醫師。

(2) 監測生命徵象。

(3) 必要時監測動脈血液氣體分析值、心電圖和脈搏血氧定量法、血氧監測器。

(4) 鼓勵咳嗽和深呼吸以維持呼吸道。

(5) 協助病童日常生活活動，評估活動無耐力的程度和提供休息時間以保留體力。

(6) 協助氣管保持衛生的方法，例如：咳嗽和深呼吸、胸部物理治療、抽吸、蒸氣吸入法等。

(7) 置病童於換氣和灌流能達最佳狀態的姿勢，例如：半坐臥、坐臥。

(8) 依醫囑給予氧氣。

(9) 依醫囑給予藥物，包括支氣管擴張劑、祛痰劑、抗生素等。

(10) 評估治療後的呼吸狀況。

5. （特定的）健康協助／對治療處置胸腔引流不瞭解

(1) 評估病童及家屬對檢查的瞭解程度。

(2) 提供衛教單張並與指導，說明檢查的目的及過程。

(3) 鼓勵病童發問及解答其疑問。

(4) 介紹成功病童，減輕其焦慮並給予心理支持。

(5) 完成檢查前的各項準備及護理。

主題名稱	小兒肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N10	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	5/10

(6)給予檢查後指導如：告知進食的時間。

(7)若有任何不適或異常，請通知護理人員。

(七) 衛教指導

1.發燒的處理

(1)衛教發燒處理的常規。36.0～37.℃：正常，37.0～38.℃：微燒冰枕及溫水擦拭浴，39.℃ 以上：高燒並於醫師指示下給予退燒藥。

(2)冷敷法-給予冰寶使用，並檢測冰寶溫度隨時更換，使用時間 20-30 分鐘，若長時間使用，至少間隔 30-60 分鐘。

(3)環境及衣物的調節。

A. 合宜的室溫 22-27℃ 溼度 60%。

B. 必要時打開窗戶，促進空氣流通。

C. 保持安靜，避免噪音。

D. 寒顫發抖時，可先加被蓋保暖。

E. 寒顫停止高燒持續時，應慢慢移除被蓋。

F. 當衣物出汗潮濕時，隨時更換。

(4)水份的補充

A. 多喝水。

B. 經由點滴補充水份及電解質。

(5)保持清潔舒適

A. 口腔護理---清潔口腔如：漱口。

B. 當口唇乾裂時可擦甘油或脣膏。

(6)適當的臥位

A. 使用枕頭被褥維持舒適臥位。

B. 協助更換姿勢。

C. 減少活動，減少體熱產生。

(7)溫水拭浴

主題名稱	小兒肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N10	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	6/10

A. 水溫 27℃~37℃，約 20~30 分鐘，促使皮膚微血管擴張，並藉由水氣蒸發而達散熱效果。

B. 以毛巾沾溫水輕拍身體四肢、腋下等部位。

(8) 飲食攝取

A. 低脂、低糖、高蛋白、高維生素。

B. 易消化的食物。

C. 依病童的喜好。

D. 可引起食慾的食物。

(9) 隨時量體溫及注意體溫變化

2. 拍背指導

(1) 病童應穿較薄的衣服，避免拍痰時產生刺痛。

(2) 拍痰時避免戴手錶、手鍊或留指甲，以避免造成傷害。

(3) 幫病童拍痰應避免在飯後做，最好在吃東西前後一小時做，以防嘔吐，拍痰一天約二到三次，若痰液較多者可每小時做一次。

(4) 拍擊時應考慮小孩的安全及舒服，應給予適當衣物來保暖。

(5) 當發現病童有痰液時，可多喝水以利痰液排出。

(6) 有些人以為努力拍痰就能除去痰液，但忽略了太粘稠的痰液，往往很難只靠拍痰排出，所以加上噴霧治療是很重要的。

3. 拍背方法

(1) 治療者弓起手呈杯狀。

(2) 仰躺頭高，由肩部往下拍前胸左右側。

(3) 臉朝下頭高，由肩部往下拍後背的左右側。

(4) 臉朝上頭低，由肋骨往肩部拍前胸。

(5) 側躺手臂提起，由腰往腋下拍擊。

(6) 臉朝下頭低，由腰往肩部拍後背左右側。

4. 噴霧吸入療法

主題名稱	小兒肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N10	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	7/10

(1)噴霧治療是利用吸入水粒子，使其附著於呼吸道內，隨氣流散播於氣管內。

痰液變濃稠不易咳出時，可利用噴霧治療稀釋痰液以利咳出。

(2)吹完藥物先休息 5 分鐘後，再使用蒸氣吸入 5 分鐘。

(3)於三餐前或飯後一小時使用（避免嘔吐），一天至少吸入 4 次，每次至少 5 分鐘。

(4)做完噴霧治療後，應立即做叩擊及姿位引流，效果更好。

(5)噴霧器每天應清洗一次，避免細菌滋生。

5.給氧的注意事項：

(1)氧氣流量勿任意的調整，應該經由醫師評估病童的狀況（疾病狀態、缺氧程度、動脈血液氣體分析等）而調整。

(2)氧氣是一種乾燥的氣體，長時間給氧要先經過濕化，觀察鼻腔及口腔黏膜有無太過乾燥或損傷情形。

(3)氧氣具有助燃性，嚴禁煙火，並懸掛告示及注意電器的使用。

(4)對於接受持續性氧療法者，切勿移除其氧氣來源，突然停止氧氣，可能造成氧分壓驟然下降。若遠離中央供氧系統，應以攜帶式氧氣筒取代。

（八）Zhang 等人(2013)實證建議：

1. 對於 0.3-18 個月病毒性細支氣管炎住院嬰兒，以高張鹽水做蒸氣吸入，對於嬰兒輕度至中度之急性病毒性細支氣管炎為一種有效、便宜和安全的治療。

2. 使用高張食鹽水執行噴霧吸入治療，成人易引發咳嗽，且 0.45%鹽水與支氣管擴張劑的結合較好，而 18 個月以下嬰兒無法自咳，用高張可以刺激咳嗽。

（九）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

主題名稱	小兒肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N10	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	8/10

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 蔡綠蓉(2021)・兒童呼吸系統疾病及其護理・於陳月枝總校閱，實用兒科護理(九版，349-424 頁)・台北：華杏。
- (二) 蔣立琦、蔡綠蓉、黃靜微、邱淑如、毛新春、吳書雅...吳佩玲(2020)・兒童呼吸系統疾病與護理・於黃美智、蔣立琦總校閱，兒科護理學(第六版，461-467 頁)・台北：永大。
- (三) 吳季芳、陳筱瑋、蔡佳琦(2022)・照顧一位嬰兒感染肺炎鏈球菌及其母親之護理經驗・助產雜誌，62，42－51。

七、附件

(略)

主題名稱	小兒肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N10	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	增加常見檢查胸腔物理治療	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	檢閱內容順暢性	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31	3.1	說明內容部份修正	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.04.07	3.2	1. 第三項第(八)目新增 Zhang 等人(2013)實證建議內容。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 04 月 07 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	1.第三項第(三)、(六)、(七)目內容刪修。 2.將參考文獻出處呈現於內文中。 3.第六項文獻參考資料更新。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第六之 2(8)修訂水溫。 3. 第三項第七目之 1(7)說明內容修訂。 4. 第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 5. 更新第六項參考文獻資料。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	小兒肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N10	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.05	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.5	1. 第三項第四目說明內容刪修。 2. 更新第三項第五目護理問題及第六目護理措施。 3. 更新第六項參考文獻資料。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.08.08	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	3.6	第三項第三目英文大小寫排版修訂	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。